

Deficit Intellettivo — Schema

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 07

Definizione (AAIDD 2022)

- **Deficit Intellettivo (DI)** → limitazioni significative in:
 - Funzionamento intellettivo
 - Comportamento adattivo
 - Con origine prima dei **22 anni**
-

3 Criteri Diagnostici

- **A. Funzionamento intellettivo** → **QI < 70** (≥ 2 DS sotto la media)
 - **B. Comportamento adattivo** → ≥ 2 DS sotto la media in almeno 1 dei 3 domini
 - **C. Età di esordio** → prima dei 22 anni
 - **⚠ Tutti e tre devono coesistere — manca uno, niente diagnosi**
-

A. Funzionamento Intellettivo

- **Comprende** → pensiero, apprendimento, ragionamento, pianificazione, imparare dall'esperienza
- **Misurato con** → test QI standardizzati (Wechsler, Stanford-Binet)
- **Media** → 100 · **DS** → 15 · **Soglia DI** → **QI < 70**
- **Curva di Gauss** → sotto 70 = **2,3%** della pop. · diagnosi DI = **1-1,5%** (perché serve anche criterio B)

Storia del QI

Chi	Cosa	Quando
Binet + Simon	Prima Scala metrica dell'intelligenza (30 prove)	1905
Binet	Padre della psicometria	1905
Stern	Introduce il termine "Quoziente Intellettivo" (EM/EC × 100)	dopo Binet
Stanford	Revisione: Scala Stanford-Binet (QI moderno)	revisioni successive

- **Formula classica** → $QI = (Età\ Mentale / Età\ Cronologica) \times 100$
- ⚠ **Limiti QI** → dato cifrato dice poco; serve profilo funzionale completo; somministrare in lingua madre

B. Comportamento Adattivo

- **Definizione** → insieme di abilità concettuali, sociali e pratiche per il funzionamento quotidiano
- **Caratteristiche** → evolutivo · dipende dal contesto · valutato su prestazione tipica (non migliore)

Tre domini

Dominio	Esempi di limitazioni
Concettuale	Pianificazione, pensiero astratto, simboli (tempo/denaro), lettura/scrittura/aritmetica
Sociale	Giudizio sociale, suggestionabilità, credulità, rischio vittimizzazione, compiacere l'autorità
Pratico	Cura di sé, gestione casa, lavoro, uso denaro, sicurezza ambiente

C. Età di Esordio

- **Limite** → 22 anni (arbitrario; prima era 18 poi 20)
 - **Scopo** → esclude la demenza (perdita capacità in età adulta)
 - **Quando** → per lo più diagnosi in prima infanzia
-

Terminologia

- **Deficit intellettivo** → termine corretto oggi
 - **"Ritardo mentale"** → obsoleto, da non usare
 - **Disabilità cognitiva** → termine più ampio (cappello)
 - Include DI + disturbi apprendimento + ADHD + difficoltà percettive sensoriali
 - ⚠ Non tutte le disabilità cognitive sono DI
-

Classificazione per intensità

Livello	QI	Sostegni
Gravissimo	0-20/25	Continuo
Grave	20/25-40/45	Estensivo
Medio/medio-grave	40/45-55	Limitato
Leggero/lieve	55-70/75	Intermittente

- ⚠ Classificazione per QI imprecisa nella pratica → meglio classificare per intensità bisogno di sostegno
-

Prevalenza

- 1-1,5% popolazione generale (DSM-5)
- Variabile per paese (dipende da cause, medicina, alimentazione)

Eziologie

Causa	%
Alterazioni sviluppo embrionale	30%
Gravidanza + periodo perinatale	10%
Ereditaria	5%
Condizioni mediche infanzia	5%
Ambientali + altri disturbi mentali	15–20%
Sconosciuta	30–40%

Fattori di rischio per periodo

- **Prenatale** → anomalie cromosomiche, malnutrizione materna, alcol (anche piccole dosi → **Sindrome Alcolica Fetale**), droghe, violenza domestica
- **Perinatale** → prematurità, ipossia al parto
- **Postnatale** → traumi cerebrali, deprivazione sociale, mancanza stimolazione, povertà

Sistemi di Sostegno

- **Scopo della diagnosi** → sviluppare profilo dei sostegni necessari
- **Effetto dei sostegni** → migliorano il funzionamento • non eliminano la disabilità

4 caratteristiche dei sistemi efficaci (AAIDD 2022)

- **Centrati sulla persona** → bisogni + desideri al centro
- **Completi** → coprono tutti i contesti di vita
- **Coordinati** → qualcuno gestisce la rete (genitori, operatori)
- **Orientati agli esiti** → impatto misurabile

Tipologie di sostegno

- **Naturali/generici** → famiglia, amici, comunità, tecnologia assistiva, ambienti inclusivi
- **Specialistici** → operatori sociali, terapeuti, didattica speciale, sensibilizzazione pubblica

Concetti correlati

- **Scaffolding** (Wood, Bruner, Ross 1976) → sostegno come impalcatura; orienta senza sostituirsi; si toglie con la crescita
- **ZSP di Vygotskij** → calibrare i sostegni vicino ai bisogni attuali; aggiornare con l'evoluzione della persona
- **SIS** (Thompson et al., 2004) → Supports Intensity Scale; misura entità dei sostegni necessari; standardizzazione italiana: Cottini et al., 2008

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
AAIDD	Definizione DI + 5 assunti + sistemi di sostegno	2022 (12° ed.)
Binet + Simon	Prima scala di intelligenza	1905
Stern	Termine "Quoziente Intellettivo"	inizio '900
Vygotskij	Zona di Sviluppo Prossimale	1978
Wood, Bruner, Ross	Scaffolding	1976
Thompson et al.	SIS – Supports Intensity Scale	2004
Cottini et al.	Standardizzazione italiana SIS	2008
Cottini, L.	<i>L'autodeterminazione nelle persone con disabilità</i>	2016

Chi	Cosa	Quando
DSM-5	Prevalenza DI: 1–1,5%	—

Parole chiave

deficit intellettivo · funzionamento intellettivo ·
 comportamento adattivo · QI · curva di Gauss · psicometria ·
 Binet · scala Stanford-Binet · disabilità cognitiva · AAIDD ·
 sistema di sostegno · SIS · scaffolding · ZSP ·
 sostegni naturali · sostegni specialistici · Sindrome Alcolica
 Fetale · ipossia · prematurità